

# AN nie jest mną — *oddziel pacjenta od zaburzenia*

AN jako odrębny byt, z którym pacjent może się zmagać. Mechanizm: dystans → możliwość obserwacji → przymierze z terapeutą przeciwko AN, nie z pacjentem.

**CZAS:** od pierwszej sesji, technika ciągła **REALIZACJA:** MANTRA, FBT (Maudsley), CBT-E faza 1-2

**ŹRÓDŁO:** White & Epston (1990, *Narrative Means to Therapeutic Ends*); Schmidt & Treasure (2013, MANTRA); Lock & Le Grange (2013, FBT)

## JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **różnica między pacjentem a AN** + mechanizm terapeutyczny eksternalizacji. Sekcja 02 — **sześć technik** stosowania w sesji: nazwanie AN, dialog, decyzje, zarysowanie. Sekcja 03 — **moje narzędzia eksternalizacji** (nazwa, charakter, pytania).

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Eksternalizacja — narzędzie narrative therapy (White & Epston, 1990) zaadaptowane do AN przez MANTRA (Schmidt & Treasure, 2013) i FBT (Lock & Le Grange, 2013). Mechanizm: AN jest *oddzielona* językowo od pacjenta — nie „*masz anoreksję*” ani „*jesteś anorektyczką*”, lecz „*AN próbuje Cię przekonać do X*”. Efekt: pacjent uzyskuje *dystans* — możliwość obserwowania AN bez utożsamienia. Konsekwencja kliniczna: **przymierze terapeutyczne staje się przeciwko AN** (terapeuta + pacjent *razem przeciwko AN*), nie wobec pacjenta („*terapeuta próbuje mnie zmusić*”). To jeden z najpotężniejszych mechanizmów obejścia ego-syntonii. Skuteczne też u rodzin — eksternalizacja zmniejsza krytycyzm rodziców („*walczymy z AN, nie z dzieckiem*”).

## 01 Pacjent kontra AN — fundamentalne rozróżnienie

### PACJENT (ZDROWA CZĘŚĆ)

**Wartości, relacje, marzenia, sens.** Chce wyzdrowieć, choć boi się. Ma swoją osobowość, historię, plany. Cierpi z powodu AN. Tęskni za życiem bez AN.

### AN (ZABURZENIE)

**Reguły, restrykcje, lęk, kontrola.** Chce się utrzymać. Mówi: „*jesteś nieważny/-a bez mnie*”, „*tylko ja Ci dam bezpieczeństwo*”. Używa głosu pacjenta, ale *nie jest pacjentem*.

**Język eksternalizacji:** „*masz AN*” / „*jesteś chory/-a*” → „*AN próbuje Cię przekonać do X*”. „*opieraj się temu*” → „*co AN Ci dziś szepcze? Czy chcesz to słuchać?*”. „*musisz zjeść*” → „*co by się stało, gdyby AN nie miała w tym głosu?*”.

**Przymierze terapeutyczne staje się przeciwko AN.** Terapeuta + pacjent *razem walczą z AN*. To zmiana w stosunku do tradycyjnego modelu, gdzie pacjent czuł się „*obiektem leczenia*”. Eksternalizacja = pacjent *staje się współpracownikiem*.

1. **Nadanie nazwy** — „Czy chciałbyś/-łabyś nazwać AN? „Ana”? „Głos”? „Tyran”? „Strażnik”?” Nazwa nadawana przez pacjenta wzmacnia sprawczość. Niektórzy: tylko „AN” lub „zaburzenie” — to też dobre.
2. **Opis charakteru AN** — „Jaki ma głos? Kobięcy/męski? Surowy/łagodny? Co najczęściej mówi? Kiedy najgłośniej?” Pacjent personifikuje AN — co dalej ułatwia z nią pracę.
3. **Zarysowanie wpływów** — „Co AN zabrała Ci w ostatnim roku? Z czego musiałeś/-aś zrezygnować przez nią?” Wymienienie konkretnych strat: relacje, hobby, marzenia. Bez minimalizowania.
4. **Dialog** — „Wyobraź sobie, że AN siedzi obok. Co ona Ci teraz mówi? Co chciałbyś/-łabyś jej odpowiedzieć?” Pacjent w wyobraźni odpowiada AN. Buduje doświadczenie sprawczości.
5. **Decyzje „kontra AN”** — „To jest decyzja, która zabolęłaby AN — co o tym myślisz?” Małe decyzje (zjeść kanapkę, spotkać się z kimś, nie ważyć się) jako „akty oporu” wobec AN.
6. **Praca z rodziną** — w FBT eksternalizacja jest kluczowa: rodzice walczą z AN, nie z dzieckiem. Zmniejsza krytycyzm: „nie jestem zły/-a na Ciebie — jestem zły/-a na AN, która Cię tak traktuje”.

### Moje narzędzia eksternalizacji — wypełnij

#### NAZWA, KTÓRĄ DAJĘ AN

— „Ana”, „Głos”, „Tyran”, „Strażnik”, lub po prostu „AN” / „zaburzenie”

#### JAKI MA „GŁOS” / CHARAKTER

— surowy, łagodny, podstępny, krytyczny; w jakich sytuacjach najgłośniej

#### TRZY RZECZY, KTÓRE AN MI ZABRAŁA W OSTATNIM ROKU

— konkretne: relacje, hobby, doświadczenia, marzenia

#### CO AN NAJCZĘŚCIEJ MI MÓWI

— typowe komunikaty: „jeszcze trochę”, „nikt Cię nie zrozumie”, „tracisz kontrolę”

#### MAŁA DECYZJA W TYM TYGODNIU, KTÓRA ZABOLAŁABY AN

— np. zjeść coś, czego unikam; nie zważyć się; spotkać się z kimś, kogo unikałem/-am

**Klucz:** eksternalizacja to *nie* manipulacja językowa — to *fundamentalna zmiana* w sposobie myślenia o zaburzeniu. AN *nie* jest pacjentem. AN jest *czymś*, co pacjent *ma*, z czym się *zмага*. Komunikat dla pacjenta: „*nie próbujemy zmienić Ciebie. Próbujemy razem osłabić AN, żebyś mógł/mogła być sobą — bez jej dyktatu*”. Eksternalizacja zmniejsza wstyd („to nie ja, to AN”) i wzmacnia sprawczość („mogę z nią walczyć”). Stosowana od pierwszej sesji.

⚠ **Ryzyko nadmiarowej eksternalizacji:** niektórzy pacjenci mogą używać eksternalizacji jako wymówki („to AN, nie ja, ja nic nie mogę”). Wówczas terapeuta przesuwaa akcent: „AN jest głośna, ale Ty decydujesz, czy słuchasz. Ty masz wybór, nawet mały”. Eksternalizacja jest narzędziem sprawczości, nie usprawiedliwiania.